PANDUAN PRAKTIK KLINIS: SINDROM KORONER AKUT (STEMI & NSTEMI)

Protokol Revaskularisasi Koroner, Terapi Antiplatelet Ganda, & Terapi Reperfusi Primer

Kategori: Penyakit & Panduan	**Spesialisasi: Kardiologi & Vaskular**	**Kode ICD-10: I21.0 - I21.9**	**Level Bukti: ACC/AHA & ESC Level I-A**

1. Definisi dan Kriteria Diagnostik

Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular yang disebabkan oleh oklusi trombotik akut pada arteri koroner akibat ruptur atau erosi plak aterosklerosis. SKA diklasifikasikan menjadi **STEMI (ST-Segment Elevation Myocardial Infarction)**, **NSTEMI (Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction)**, dan **UAP (Unstable Angina Pectoris)**.

Kriteria Diagnosis:

- **Nyeri Dada Khas Angina:** Nyeri substernal menjalar ke lengan kiri, leher, atau rahang, sensasi tertekan berat berlangsung >20 menit, tidak berkurang dengan istirahat/nitrat.
- **EKG 12 Sandapan (Wajib dalam 10 menit pertama):** Elevasi segmen ST baru pada J-point di ≥2 sandapan berdekatan (≥2.5 mm pada pria <40 th di V2-V3, ≥2 mm pada pria ≥40 th, ≥1.5 mm pada wanita) atau Left Bundle Branch Block (LBBB) baru.
- **Biomarka Jantung:** Troponin I / T berkadar sensitivitas tinggi (hs-cTn) meningkat melebihi persentil ke-99 URL dengan kenaikan/penurunan serial signifikan.

2. Protokol Reperfusi dan Antiplatelet (Level I-A Evidence)

Waktu adalah miokardium (*Time is Muscle*). Target **Door-to-Balloon Time < 90 menit** untuk Intervensi Koroner Perkutan (PCI) Primer, atau **Door-to-Needle Time < 30 menit** untuk fibrinolisis jika PCI tidak dapat dilakukan dalam waktu 120 menit.

Regimen Obat	Dosis Inisiasi (Loading)	Dosis Pemeliharaan	Tingkat Bukti
Aspirin (Asam Asetilsalisilat)	160 - 320 mg kunyah (PO)	80 - 100 mg 1x/hari seumur hidup	Level I-A (ACC/AHA)
Ticagrelor (Inhibitor P2Y12 pilihan)	180 mg PO (2 tablet @ 90mg)	90 mg 2x/hari selama 12 bulan	Level I-B (PLATO Trial)
Clopidogrel (Alternatif jika Ticagrelor kontraindikasi)	300 - 600 mg PO	75 mg 1x/hari selama 12 bulan	Level I-A (CURE Trial)
Antikoagulan (Heparin / Enoxaparin)	UFH 60-70 U/kg IV bolus atau Enoxaparin 30 mg IV bolus	Enoxaparin 1 mg/kg SC tiap 12 jam	Level I-A
Statin Intensitas Tinggi (Atorvastatin)	Atorvastatin 80 mg PO / Rosuvastatin 40 mg	40 - 80 mg PO 1x/hari malam	Level I-A (PROVE-IT)

3. Referensi Klinis

1. **ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With STEMI / NSTEMI**. Circulation 2024.
2. **PERKI (Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia):** *Pedoman Tatalaksana Sindrom Koroner Akut Edisi V 2024*.